

CANNABACEAE · Δ⁹-THC · SUBSTÂNCIA PERTURBADORA DO SNC

Maconha

Cannabis sativa L.

O que é, como age na mente e no corpo, quais os riscos psicológicos e o que dizem os dados mais recentes sobre a droga ilícita mais consumida do mundo.

Seminário de Psicologia

Composição · Efeitos · Malefícios · Dados



Cannabis sativa L. · família Cannabaceae

O que é a maconha?

Maconha é o nome popular da preparação obtida das folhas e flores secas da planta **Cannabis sativa**. É uma droga psicoativa classificada como **perturbadora do sistema nervoso central**, porque altera a percepção, o humor e a consciência de quem a consome.

01 Centenas de compostos

A planta reúne mais de 400 substâncias químicas; dezenas delas são canabinoides, os compostos responsáveis pela ação no organismo.

02 Dois protagonistas

O THC (tetra-hidrocanabinol) responde pelos efeitos psicoativos; o CBD (canabidiol) não é intoxicante e tem potencial terapêutico.

03 Sistema endocanabinoide

Os canabinoides agem em receptores naturais do corpo (CB1 e CB2), que regulam memória, prazer, apetite, dor e coordenação.

+ Inalada (fumo / vaporização)

↓ Ingerida (óleos / alimentos)

○ Sublingual / tópica

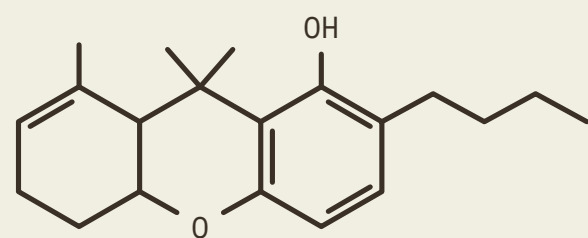
A forma de uso muda o efeito: inalada, age quase de imediato; ingerida, demora mais a aparecer, mas dura mais tempo.



Cannabis sativa · ilustração da planta

THC × CBD

Os dois compostos mais estudados da cannabis têm estruturas parecidas, mas efeitos quase opostos sobre a mente.

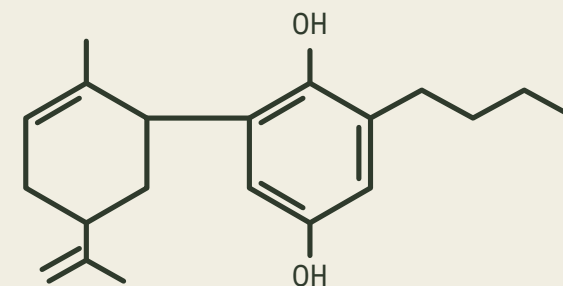


PSICOATIVO

Tetra-hidrocanabinol

Δ^9 -THC · C₂₁H₃₀O₂ · isolado em 1964

- Causa a euforia, o relaxamento e a alteração da percepção — a "chapação"
- Principal responsável pela dependência e pelos efeitos nocivos
- Também tem ação analgésica, antiemética e estimulante do apetite



NÃO INTOXICANTE

Canabidiol

CBD · C₂₁H₃₀O₂ · sem "barato"

- Não provoca alteração da consciência nem euforia
- Potencial ansiolítico, anticonvulsivante, antipsicótico e anti-inflamatório
- Parece proteger os neurônios de parte dos danos causados pelo THC

Atenção: ao fumar, a pessoa não recebe THC ou CBD isolados, e sim uma mistura sem dosagem controlada. Nas últimas décadas, o teor de THC nas variedades consumidas vem aumentando e o de CBD diminuindo — o que eleva os riscos para a saúde mental.

Como age no cérebro

O THC imita a anandamida — um canabinoide que o próprio corpo produz — e se liga aos receptores **CB1**, abundantes nas regiões que controlam memória, prazer, emoção e movimento.



- **Córtex pré-frontal**
Julgamento, atenção e tomada de decisão — daí o raciocínio mais lento e o juízo alterado.
- **Hipocampo**
Memória e aprendizado: explica a falha na memória recente e a dificuldade de fixar informações.
- **Núcleos da base / recompensa**
Liberação de dopamina e sensação de prazer — a base do potencial de dependência.
- **Amígdala**
Emoção e medo: ligada aos episódios de ansiedade, paranoia e crises de pânico.
- **Cerebelo**
Equilíbrio e coordenação motora — perda de coordenação e reflexos mais lentos.

Efeitos imediatos do uso

Logo após o consumo, surgem efeitos psicológicos e físicos que variam conforme a dose, a potência da planta e as características de cada pessoa.



Mente e comportamento

- **Euforia e relaxamento**, sensação de bem-estar e riso fácil
- **Alteração da percepção** do tempo, das cores e dos sons
- **Prejuízo da memória recente**, da atenção e da concentração
- **Julgamento alterado** e reflexos mais lentos
- Em parte dos casos: **ansiedade, paranoia ou crises de pânico**



Corpo

- **Aumento do apetite** — a popular "larica"
- **Olhos avermelhados** e boca seca
- **Taquicardia** — coração acelerado, sobretudo nos primeiros 30 minutos
- **Queda de pressão** ao levantar, com tontura
- **Perda de coordenação motora** e do equilíbrio

Início e duração: fumada, a maconha faz efeito em minutos e dura algumas horas; ingerida (óleos e comidas), o efeito demora mais para começar, é mais difícil de dosar e se prolonga — o que aumenta o risco de superdosagem acidental.

Riscos para a mente

É na esfera psicológica que estão os efeitos mais preocupantes do uso crônico — especialmente quando começa cedo, é frequente e envolve cannabis de alta potência.

Psicose e esquizofrenia

O uso aumenta o risco de surtos psicóticos e de esquizofrenia, sobretudo em pessoas com predisposição genética. Quanto mais cedo e mais intenso o uso, maior o risco.

↑ até 4× quando iniciado aos 15 anos

Ansiedade e depressão

Pode desencadear ou agravar transtornos de ansiedade, transtorno de pânico, depressão e alterações de humor, principalmente com uso contínuo e em altas doses.

início ou piora de sintomas

Síndrome amotivacional

Em usuários jovens e frequentes, observa-se apatia, desânimo e conformismo, com prejuízo da organização do pensamento, do planejamento e das decisões.

apatia · desmotivação

Cognição e cérebro em formação

Na adolescência, o uso interfere no desenvolvimento cerebral e pode reduzir o QI, além de prejudicar memória, atenção e aprendizado de forma duradoura.

redução de substância cinzenta

⚠ Honestidade científica: a relação de causa entre maconha e esquizofrenia ainda é debatida — parte do risco se explica por vulnerabilidade prévia. Para o uso ocasional, não há evidência robusta de dano permanente. O perigo cresce com início precoce, frequência alta e cannabis rica em THC.

Riscos físicos e dependência

Apesar da fama de droga "leve", a maconha causa dependência e afeta vários sistemas do corpo — em especial os pulmões e o coração.

Dependência

Cerca de 1 em cada 3 usuários desenvolve dependência: fissura, perda de controle e dificuldade de parar, mesmo querendo.

≈ 1/3 dos usuários

Pulmões

A fumaça tem alcatrão e irrita as vias aéreas: tosse crônica, bronquite e maior chance de problemas respiratórios.

alcatrão · bronquite

Coração e circulação

Taquicardia e oscilação de pressão; estudos associam o uso a maior risco de infarto, arritmias e AVC, sobretudo em jovens.

↑ risco cardiovascular

Gestação

O uso na gravidez está ligado à redução do crescimento fetal e a efeitos no desenvolvimento do bebê.

risco ao feto



Folha de Cannabis sativa · folíolos serrilhados

Números e curiosidades

228 mi

usuários no mundo em 2022 — a droga ilícita mais consumida (ONU)

~10 mil

anos de uso pela humanidade, com fins medicinais, rituais e têxteis

7,7%

dos brasileiros (12–65 anos) já experimentaram ao menos uma vez (Fiocruz)

1964

ano em que o THC foi isolado pela primeira vez, em Israel

Mundo

Crescimento contínuo: os usuários saltaram de 192 milhões (2016) para 228 milhões (2022). Na Europa, 11,7% dos jovens de 15 a 34 anos usaram no último ano.

Potência

Cada vez mais forte: o teor de THC vem subindo e o de CBD caindo ao longo das décadas — tornando a cannabis atual mais arriscada do que a de gerações anteriores.

História

Já foi remédio comum: indicada no passado para asma, tosse e dores, e cultivada pelo cânhamo (fibra). O cânhamo industrial acompanha a humanidade há milênios.

Mundo

Legalização recreativa: Uruguai e Canadá são pioneiros em regular o uso adulto da maconha, contrariando o senso comum sobre quais países mais consomem.

📍 No Brasil hoje

Em **2024, o STF descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal**, fixando **40 gramas ou 6 plantas fêmeas** como parâmetro para diferenciar usuário de traficante. O porte continua sendo ato ilícito, mas passou a ter consequência **administrativa** (advertência e medidas educativas), e não criminal. O uso medicinal de produtos à base de canabidiol é regulamentado.

— REFERÊNCIAS

Fontes consultadas

Levantamento baseado em instituições de saúde, universidades, sociedades científicas e órgãos oficiais.

01	MD.Saúde — Maconha (Cannabis sativa): efeitos agudos e crônicos mdsaude.com/dependencia/marijuana-maconha
02	Manual MSD — Canabidiol (CBD) msdmanuals.com/pt/casa
03	Secretaria de Estado de Saúde / MS — Substâncias da maconha saude.ms.gov.br/substancias-da-maconha
04	Revista Brasileira de Psiquiatria (SciELO) — Efeitos cerebrais da maconha: neuroimagem scielo.br/j/rbp
05	SciELO/RBP — Uso de maconha na adolescência e risco de esquizofrenia scielo.br/j/rbp
06	Pepsic — Consequências neuropsicológicas do uso da maconha em jovens pepsic.bvsalud.org
07	Jornal da USP — A maconha causa transtornos mentais? jornal.usp.br

08	Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) — Maconha e esquizofrenia abp.org.br
09	UFRGS / farmacoLÓGICA — Maconha e esquizofrenia ufrgs.br/farmacologica
10	UNIAD / Unifesp — Relatório da ONU sobre o uso de cannabis uniad.org.br
11	ONU Brasil / OMS — Cannabis, a droga ilícita mais consumida brasil.un.org
12	Agência Brasil — Decisão do STF sobre porte de maconha agenciabrasil.ebc.com.br
13	Câmara dos Deputados — Histórico das drogas no mundo camara.leg.br
14	LENAD II / Unifesp — Levantamento Nacional de Álcool e Drogas: Maconha febract.org.br

Material educativo elaborado para seminário acadêmico de Psicologia. As informações têm caráter informativo e não substituem orientação médica. Se você ou alguém próximo enfrenta problemas com o uso de drogas, o atendimento é gratuito pelo SUS (CAPS-AD). Estruturas químicas em representação esquemática.